

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231570456 | 423

EMERSON DE ANDRADE RAMOS

IDADE: 50 PESO: 103 ALTURA: 1,70 PROFISSÃO: Autônomo (cunhagem / manutenção)
SINTOMAS: sonolência diurna / ao dirigir; sudorese noturna.

QUEIXAS: dor no ombro; ganho peso há 5 anos; Acorda cansado; desanimado
MEDICAMENTOS: Sildenafil, Serpinin, (Desire Amado → Amelhora Ansiedade depressiva)
Levotamara MAS 2018

MÉDICO: Dr. Rômulo → Pneumologista / Dra Sônia Rachid Infecto 2018

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: está desmotivado (fazia Bike)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 5x noite

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 29,1 e/h SPO2: 85%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Bronquite / Asma

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Faz uso Sildenafil diário / Serpinin crise

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

04/10/24 Avaliação Auto 4 à 12 cmH₂O Másc N30: (N) Silêncio

11/10/24 Auto 4 à 10 cmH₂O EPR: 3 (CPAP pct gases)

P: 9,7 cmH₂O * compra Elite *

IAH = 2,2 e/h

másc = 7h40

fuga = 12 l/min

Deixo P. fixa 9,8 cmH₂O

18/10/24 P: 9,8 cmH₂O melhora disposição

IAH = 0,8 e/h mas queixa de despertar a noite por mta

másc = 7h03 menos de ar

fuga = 15 l/min

opto ↓ P: 9,6 cmH₂O Silêncio

30/10/24 P: 9,6 cmH₂O Relata ainda despertar a noite sentindo mta

IAH = 0,6 e/h pouco de ar

másc = 6h46 min

fuga = 9 l/min

↓ P: 9,0 cmH₂O

Está bem mais disposto

27/11
24

$P = 9,00 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m de uso: 7h40'
fluxo: 2,8 l/m

Dilata esta melhor
adaptado cl cpap
nova punção

Natasha

24/01/25

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m de uso: 7h58'
fluxo: $\emptyset$

Bem adaptado
Comprei monge cl pillow

*troco filtro

Natasha

02/09/25

(pot não estava
no sistema)

~~Hub Dorte~~ ~~Silvia~~
 $P: 9,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8$
m de uso: 8h37min
fluxo: 3l/min

Bem Adaptado

(toco monge P30: M)
" filtro
" traqueia

Silvia

Nome: EMERSON DE ANDRADE RAMOS
Data de Nascimento: 25-10-1974
IMC: 35,29
Sexo: Masculino
Data do exame: 23-07-2024

Peso: 102 kg
Altura: 1,70 m
Médico: DR. RAMIRO SIENRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 23-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletroculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 484,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 18,5 e 167,5 minutos. O tempo total de sono foi de 369,5, eficiência de 76,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 63,3%; estágio N3: 14,1%; sono REM: 20,6%. O índice de despertares foi de 15,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 29,1/hora, sendo elas 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 177 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 91% e mínima de 85%, permanecendo 8,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 60 - 97 bpm e NREM de 63 - 105 bpm.

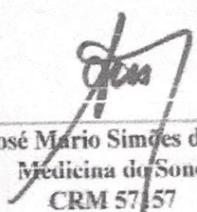
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 29,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂=85%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157